Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Haben Sie Brustschmerzen, Luftnot oder ein Engegefühl?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach dem Essen?
Was haben Sie gegessen?
Wo haben Sie das gegessen?
Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Symptome hat?

Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?
Wurden Sie schon einmal operiert?

Haben Sie Fieber?
Seit wann?
Haben Sie die Temperatur gemessen?
Wie hoch war sie?
Wo haben Sie gemessen?
Haben Sie Schüttelfrost?
Schwitzen Sie mehr als sonst oder haben Sie Schweißausbrüche bzw. Nachtschweiß?

Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Haut in der letzten Zeit gelb geworden ist?
Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?
Wie oft?

Wie sah das Erbrochene aus? Welche Farbe und Konsistenz hatte es?
Gab es Blut im Erbrochenen?

Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Seit wann?
Wie oft?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl?
Gibt es Blut im Stuhl?

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin?
Gibt es Blut im Urin?
Haben Sie verstärkten Durst bemerkt?
Wie viel Wasser trinken Sie täglich?

Haben Sie Völlegefühl oder Blähungen?

Können Sie wegen der Schmerzen schlecht schlafen?
Fühlen Sie sich müde?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?
Was essen Sie normalerweise? Essen Sie gerne Fleisch, Wurst, Sahne, Käse oder fetthaltige Speisen?
Warum nehmen Sie Magnesium?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf Gallensteinleiden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie – Ultraschall:

Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet. Das ist nicht nur bei Schwanger, wir können damit alle inneren Organe beobachten.
Haben Sie an mich noch Fragen?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von 2,6 mmol/L hat. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.

Es geht um Frau Rose-Marie Hagen. Sie ist 59 Jahre alt, am 01.01.1963 geboren, 165 cm groß und wiegt 71,3 kg.
Sie stellt sich bei uns wegen seit zwei Stunden bestehender kolikartiger, dumpfer und progredienter Bauchschmerzen im rechten Oberbauch vor.
Laut Angaben der Patientin sind die Schmerzen plötzlich postprandial (nach dem Verzehr von Makrelen-Röllchen) aufgetreten.
Sie berichtet, dass die Schmerzen in die rechte Schulter ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 8/10 auf der Schmerzskala liegt.

Sie erwähnt, dass sie seit 2–3 Wochen ähnliche Beschwerden hat, aber die Schmerzen im Verlauf schlimmer geworden sind.
Begleitend klagt sie über Nausea seit einer Woche, Vomitus seit heute Morgen dreimal, mit Speisereste und Galle.
Außerdem hat sie Diarrhoe seit einer Woche, wässrig und braun, dunkler Urin und

Durst.
Vegetativanamnestisch ergaben sich Müdigkeit und Menopause seit 8 Jahren.
Ansosnten war die Wegetativanamnese unauffällig.
Die Vorerkrankungsanamnese war unauffällig.
Sie nannte folgende Operationen: Z. n. totaler transvaginaler Hysterektomie vor 3 Jahren, Z. n. Tonsillektomie mit 10 L. J.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Magnesium unklare Dosis (1-0-0), ASS 100 mg (1-0-0) als Prophylaxe seit 30 Jahren, Venoruton 300 mg (1-0-0) gegen chronische venöse Insuffizienz.
Die Allergieanamnese ergab eine Allergie gegen Nickel, die sich in Pruritus und Urtikaria äußert.
Bei der Noxenanamnese erwähnte sie zwei Gläser Wein oder Champagner am Wochenende.
Die Familienanamnese ergab Apoplex und Herpes zoster beim Vater sowie MI, DM Typ II und Adipositas bei der Mutter. Sie ist mit 65 L. J. plötzlich verstorben.
Sozialanamnestisch ist sie Managerin ihres Mannes, verheiratet und hat zwei Töchter.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Cholelithiasis hin.
Die kolikartigen rechtsseitigen Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die rechte Schulter, dunkler Urin, Nausea, Vomitus und Diarrhoe sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen akute Pankreatitis, akute Gastroenteritis und ACS in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen. Auch ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um eine Herzerkrankung auszuschließen.
Bei der körperlichen Untersuchung werde ich Courvoisier-Zeichen, Murphy-Zeichen und Ikterus überprüfen.
Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter (CRP), Cholestaseparameter (ALP, Gamma-GT, Bilirubin), Lipase, Amylase, Herzenzyme (Troponin I/T, CK-MB), Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Lipidprofil, ggf. einen Urinstatus sowie ggf. eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) kontrollieren lassen.
Anschließend werde ich eine Sonographie des Abdomens, ggf CT-Abdomen und ggf. MRCP durchführen und ein Konsil in der Abteilung für Chirurgie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, sollte die Patientin stationär aufgenommen werden.
Als initiale Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, magenschonende Ernährung, Nikotinkarenz, Alkoholkarenz sowie symptomatisch die Gabe eines Analgetikums (z. B. Metamizol) und eines Antiemetikums bei Bedarf, ggf. präoperativ ein Antibiotikum (Ceftriaxon).Die Steingröße spielt eine wichtige Rolle bei der Therapieentscheidung.

Bei Choledochussteinen ≥ 10 mm ist eine ERCP in der Regel indiziert, da ein spontaner Abgang unwahrscheinlich ist.

Für eine medikamentöse Auflösung in der Gallenblase kommen meist nur kleine, nicht verkalkte Steine ≤ 5–10 mm in Frage; größere Steine werden eher operativ behandelt.

Die medikamentöse Steinauflösung mit UDCA wird nur bei Gallenblasensteinen eingesetzt. Bei Choledochussteinen ist sie nicht geeignet; hier ist eine ERCP mit Steinextraktion die Therapie der Wahl.

Das wäre zunächst dem Relevanten.- Bu aşamada önemli / gerekli olan şey şimdilik bunlar.
„Das wäre zunächst das Relevante zu diesem Fall.“
(= Bu vakayla ilgili önemli kısım şimdilik bu kadar.)

Reaktionen:

Ich habe Übelkeit und Schmerzen, könnten Sie mir helfen? Pyelonephritis - Cholelithiasis

- Ja, wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
- Ich verstehe, dass Sie Beschwerden haben, aber ich brauche einige weitere Informationen.
- Könnten Sie die Schmerzen noch ein bisschen aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist? Prima! Auf jeden Fall wäre das besser für die Diagnose.
- Ich versuche möglichst schnell zu beenden.

Soll ich operiert werden? Cholelithiasis

Davon geht es erstmal nicht aus. Es ist jetzt zu früh zu entscheiden. Ich informiere Sie alles nach den Untersuchungen.

Was ist Bauchultraschall? Cholelithiasis

Bauchultraschall ist eine bildgebende Untersuchung des Bauches. Durch diese Untersuchung können wir die inneren Organe mithilfe von Schallwellen darstellen und ihre Funktion beurteilen.

Soll ich hierbleiben? Ich will nach Hause, um meine Sachen zu bringen. Cholelithiasis

- Sie sollen bei uns bleiben, bis alle Ergebnisse vorliegen. Es könnte für Sie im Moment gefährlich sein, nach Hause zu gehen. Wir können für Ihre Sachen eine Lösung finden.
- Wir empfehlen Ihnen dringend, im Wartebereich zu bleiben, bis alle Untersuchungen vorliegen, damit wir schnell reagieren können, falls es zu etwas schlimmes kommt.
- Im Wartebereich stehen Ihnen Wasser und eine Kantine zur Verfügung, falls Sie etwas benötigen.

Warum fragen Sie nach Drogen? ACS – Florian / Cholelithiasis / akutes Abdomen / OSAS / Reizdarm

- Diese Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Drogen haben viele Nebenwirkungen. Deshalb muss ich fragen.
- Wenn Sie ja sagen, dann würden wir die Dosis Ihrer Medikamente anpassen.
- Wenn Sie eine Entzugstherapie benötigen, dann kann ich die anbieten.
- Machen Sie sich keine Sorgen, ich gebe Ihre Angaben nicht weiter. Das ist unsere Regel.

- Grey-Turner-Zeichen = grünlich Hautveränderung an den Flanken (Ekchymosen), Cullen-Zeichen = " um den Nabel ❑ Nekrotisierende Verlauf
  - Labor: erhöhte **Lipase**, Amylase, Cholestase-Parameter +/- Hyperglykämie
  - Abdo-**Sonographie**
  - MRCP
  - Abdo-CT bei Verdacht auf Komplikationen
- Komplikationen: Hypovolämischer Schock, Abszess, Pseudozysten, Nekrose, Chronifizierung
- Therapie:
  - Konservativ: Volumen- Elektrolytsubstitution (Ringer-Laktat-Infusion), Nulldiät (keine Feste Nahrungsmittel), Analgetikum, Plasmapherese (bei Hypertriglyzeridämie über 1000 mg/dl), Antibiotikum (Carbapenem, Ceftriaxon, Metroidazol), PPI
  - Interventionelle: endoskopische Drainage / Spülung / Resektion der Nekrosen +/- ERCP

- **Chronische Pankreatitis**
  - Ätiologie: Alkoholabusus +/- Tabakrauchen, Hypertriglyzeridämie, primärer Hyperparathyreoidismus mit Hyperkalzämie
  - Pathophysiologie: die Aktivierung der proteolytischen Pankreasenzyme, die zu einer Autodigestion des Organs ❑ Kalzifikation
  - Symptome:
    - starker, nicht kolikartiger Schmerz, gürtelförmig, beidseitig ausstrahlend, rezidivierend
    - durch Maldigestion: **Gewichtsverlust**, **Steatorrhö**, Meteorismus, Diarrhö, Flatulenz
    - diabetische Stoffwechselzustände bei endokriner Pankreasinsuffizienz
    - Ikterus
  - Diagnostik:
    - Labor: **Hypokalzämie**, erhöhte Tumormarker (**CEA**), ggf. verminderte Komplementfaktoren (C3, C4), **Elastase-1 im Stuhl** (< 100 µg = exokrine Pankreasinsuffizienz)
    - **Abdo-Sonographie**: Zeichen einer chronischen = Verkalkungen, Pankreaspseudozysten ❑ deuten eher auf eine alkoholische Pankreatitis
  - Komplikationen: Fistelbildungen, Pseudozysten, Pankreaskarzinom
  - Therapie: gleich mit akute + antidiabetische Therapie bei einer endokrinen Pankreasinsuffizienz / Pankreatin bei exokrine Pankreasinuffizienz
    - Operative: duodenumerhaltende Pankreaskopfresektion (= Whipple-Operation)

13. Choledocholithiasis s.110 Cholelithiasis

Arzt-Patient-Gespräch

der Schalttag -> 29. Sobat
das Schaltjahr - artz
y.l

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Rose-Marie Hagen
- 59 J.
- *01.01.1963: ich wurde am 1. Tag des Jahres 1963 geboren
- 1,65 m
- 71,3 kg

-Hauptbeschwerde

- **Rechter Hypochonder**: Oberbauch recht Schmerzen
  - **Kolikartig** (Wellenformig), **dumpf**
  - **Ausstrahlung**: ja mein Schmerz strahlt in die rechte Schulter aus
    - Ich spiele Golf, ich denke, dass die Schmerzen wegen Golfarm sind
  - **Auslöser: Nach dem Verzehr von Makrelen-Röllchen** ***(= kleine Röllchen mit Makrelenfilets)***
    - ich war in der Kanzlei meines Mannes (Büro eines Rechtsanwalts oder einer Behörde)
  - **Plötzlich angefangen**
  - **8/10**: ~~Könnten Sie mir ein Schmerzmittel geben?~~ Konnten Sie die Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten? Soll ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben?
  - **Progredient: seit 2-3 Wochen ähnliche Beschwerden**, die im Laufe der Zeit verstärket haben
    - Hatten Sie schon mal solche Schmerzen? Haben Sie eine Allergie gegen bestimmte Medikamente?
  - **Kein Minderungs- oder Verschlechterungsfaktor**
- **Nausea**: Übelkeit seit 1W.
- **Vomitus**: Erbrechen: 3 mal seit heute Morgen (Essensreste und Gallen)
  - Wie sah das Erbrechen aus?

- Haben Sie ein Völlegefühl? Blähungen? **(Meteorismus)**
- Gehen Winde ab?
- Wann war der letzte Stuhlgang?
- Wann war die letzte Mahlzeit?

-vegetative Symptomatik

- **Diarrhoe**: Durchfall **seit 1 Wo, wässrig, ohne Blut**
  - Wie sieht Durchfall aus?
- **Wasserlassen**: mein Wasser ist sehr dunkel, ich verstehe es nicht, weil ich viel trinke, ich habe großen Durst
  - Trinken Sie mindestens 1,5L Wasser pro Tag?
- **Adynamie, Fatigue**: Müdigkeit: und ich fühle mich sehr müde, als ob ich keine Energie mehr hätte

-gyn

- **Menopause vor 8 J.**: ich habe seit acht Jahren meine Periode nicht mehr und bin sehr zufrieden damit!

-Vorerkrankungen

- keine

-Vor-OPs

- **Totale-OP/transvaginale-Hysterektomie vor 3J.**: Vor drei Jahren wurde mir die Gebärmutter entfernt, und zwar durch die Vagina. Es war eine große Operation, aber wenigstens habe ich keine Narben. ~~Ich kann weiterhin im Bikini an den Sandstrand gehen, hahah!~~ Ich sehe, dass Sie die Situation mit Humor nehmen, das ist gut.
- **TE mit 10 LJ.**: Ach ja, und meine Mandeln wurden mir auch entfernt, als ich zehn Jahre alt war.

-Medikation

→ mit humor nehmen → bit seyi gülerek karşılamak

- **Magnesium unklare Dosis 1-0-0** (wg. Müdigkeit, Muskelkrämpfe)
- **ASS 100 mg 1-0-0 (als Prophylaxe seit 30 J.)**: ~~Meine Cousine hat das empfohlen.~~
  - Es ist nicht gut, Medikamente ohne den Rat Ihres Arztes einzunehmen. Es kann viele Nebenwirkungen verursachen.
- **Venoruton 300 mg 1-0-1 (wg. chronischer venöser Insuffizienz = CVI)** empfehlen bei meinem Hausarzt ~~„Ich habe ein chronisch-venöses Stauungssyndrom". Kennen Sie das?~~
  - Ja kenne ich, tragen Sie auch Kompressionsstrümpfe? Seit wann leiden Sie an dieser Krankheit? Ihre Beinvenen arbeiten nicht mehr richtig, dadurch sammelt sich das Blut in den Beinen.

-Allergien

- **Nickelallergie (Pruritus und Urtikaria)**: Juckreiz und Nesselsucht
  Ortizer Ekzemlar

3

-Noxen

- Tabak: nicht Raucherin
- C2: 2 Gläser Wein oder Champagne am WE und Cocktail Hugo: mit Freunden in Golfclub,
  - ~~Wissen Sie was Hugo ist?~~ Kopozls bempsoiuf
    - ja ich kenne, das ist ein Cocktail mit Minze und Prosecco. ~~Lecker im Sommer~~ None Soda, Holunderblütensirup
- Keine Drogenkontakt
  - ~~Warum fragen Sie danach? Wenn ich ja sage, was machen Sie denn?~~
    - Das ist nur um Sie so gut wie möglich zu behandeln. Drogen können Nebenwirkungen mit bestimmten Medikamenten haben weil Drogen Wechselwirkung mit anderen Medikamenten haben kann, könnte Ihnen vielleicht Medikament verändern.

-Sozialanamnese

Aufgrund der Schweigepflicht werde ich Ihre Angaben mit niemandem teilen

- Jetzt Managerin meines Mannes, früher Kauffrau
  - Arbeiten Sie vollzeit? Sind Sie damit zufrieden?
- Verheiratet (~~letzte W. haben wir unsere Silberhochzeit gefeiert~~)
  - Herzlichen Glückwunsch zu einem Vierteljahrhundert Hochzeit!
- 2 Töchter
- Wohnt mit ihrem Mann (Rechtsanwalt) zusammen

-Familienanamnese

- Vater: Z.n. Apoplex (vor 19 J.), sitzt im Rollstuhl, im Pflegeheim, vor einer Wo. Herpes zoster
  - mein Vater hatte vor 19 Jahren einen Schlaganfall und sitzt seitdem im Rollstuhl im Pflegeheim
  - Vor einer Wo. hat er Gürtelrose. ~~Ist das ansteckend?~~
    - Gürtelrose kann ansteckend sein, wenn Sie niemals die Windpocken hatten (in direkten Kontakt mit den Bläschen). → Dysodo bilg:
- Mutter: t mit 65 LJ. Plötzlich gestorben an MI, DM-Typ 2, Adipositas

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fr agen fertig.
Ich habe einen Verdacht auf Gallensteinleiden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann ein wenig Blut abnehmen. Wir werden auch einen Bauchultraschall durchführen, wissen Sie was das ist?

Sonographie:
Das ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die circa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch auftragen, und wir werden mit eine Kopfsonde Ihre inneren Organe beobachten. Das ist nicht nur bei Schwangerschaft, wir können damit alle inneren Organen beobachten.

-Fragen Ich habe einen Verdacht auf Gallensteinleiden.

- Was habe ich? Was ist Bauchultraschall? Soll ich hier bleiben? Ich will nach Hause, um meine Sachen zu bringen. Soll ich operiert werden? → vielleicht kann jemand Ihre Sache ins Krankenhaus bringen.

Es ist jetzt zu früh zu entscheiden. Ich informiere Sie alles nach der Untersuchung

Momentan kann ich nicht genau wissen, wir warten auf die Befunde der Untersuchung, dann können wir entscheiden.

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Rose-Marie Hagen, 61** Jahre alt, die in gutem AZ (Allgemeinzustand) und übergewichtigem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 2 Stunden und undulierende, kolikartige abdominale Schmerzen in rechten Hypochondrium (= regio hypochondriaca dextra), die in die rechten Schulter

ausstrahlen. Die Schmerzen haben plötzlich begonnen nach dem Verzehr von Makrelen-Röllchen (= Postprandial), aber waren seit 2-3 Wochen progredient. Jetzt 8 von 10 auf einer Schmerzskala.

Begleitend ist seit 1 Woche Nausea und heute Morgen Emesis 3 Mal mit Essensreste und Gallen. Auch wässrige Diarrhoe, dunkele Urin und Adynamie (Fatigue).

Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.

Sie nimmt regelmäßig Magnesium morgens, Venoruton 300 mg wegen CVI, und seit 30 Jahre regelmäßig ASS 100 mg.

In der Familienanamnese gibt es DM-Typ-2

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Cholelithiasis. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Cholezystitis, Akute Pankreatitis, Ulcus ventriculi, akute Gastroenteritis, ACS.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung (Courvoisier-Zeichen, Murphy-Zeichen, Ikterus) durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, CRP, BSG, ggf. PCT, Gerinnungsparameter (PT), Amylase, Lipase, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Herzenzyme (Trop.I, T, CKMB), Glukose. Ggf. Stuhlprobe.

Anschließend ist eine Sonographie des Abdomens. Auch sollte ein Ruhe-EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache zu vermeiden. Weiterführend ist ein chirurgisches Konsil anzufordern.

Ich werde sie stationäre aufnahmen.

Als Therapie schlage ich initial/symptomatisch Flüssigkeits und Elytsubstitution (Infusiontherapie), Antiemetika, Antipyretika, Analgetikum (Metamizol) b.B., **Magenschonende** Ernährung (Nikotinkarenz und Alkoholkarenz) vor. Ggf. prä-op Antibiotikum (Ceftriaxone)
Bei gesicherter Verdachtsdiagnose und

- bei Steinen über 2 cm Durchmesser empfehle ich eine **ERCP** (= endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie)
- Bei Steinen unter 2 cm, eine medikamentöse **Litholyse = Auflösung** der Steine (mittels Ursodeoxycholsäure) wird durchführen.
- Bei einer Cholezystolithiasis oder Unzugänglichkeit der Gallenwegssteine via ERCP, machen wir eine **laparoskopische Cholezystektomie**.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

BMI wird berechnet, indem man das Gewicht im Kilogram durch die Körpergröße im Meter zum Quadrat teilt.

Welche EZ hat die Patientin? Übergewichtig

Was ist BMI und dessen Formel? Body mass index = Gew. (kg) / Größe (cm)^2 = 26,2 Übergewicht

BMI zeigt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße, dient zu Beurteilung ob jemand untermormal, normal oder übergewicht ist.

Was ist Schmerzskala? Nachteile und Alternative

- = Mit einer Schmerzskala misst man die **subjektive Schmerzstärke** des Patienten.
- Nachteil: diese Methode ist **subjektiv**
- Alternative: **Visuelle Analogskala** (VAS), Numerische Rating-Skala (NRS), Verbale Rating-Skala (VRS), **Smiley-Analogskala** (SAS), Faces Pain Scale-Revised (FPS-R), KUS-Skala (KUSS)

keine Schmerzen / leicht / mittel / starke

Kindliche Unbehagens (Behandlung) und Schmerzskala

Was ist Kanzlei? Büro eines Rechtsanwalts oder einer Behörde

Was ist Omarthrose? Schultergelenksarthrose *(Gelenkverschleiß)*

Welche operativen Zugangswege gibt es für Hysterektomie?

- Offene transabdominale Organentfernung = Laparotomie
- laparoskopisch-Organentfernung

- Transvaginale Organentfernung
- Kombination beider Techniken

Was ist Total-OP? die komplette operative Entfernung des Uterus mit zusätzlicher Entfernung der Adnexe (Tuba uterina, Ovar, Epoophoron = Nebeneierstock)

Komplikationen:

- Verletzung der Nachbarorgane (Harnblase)
- Wundheilungsstörung
- Infektionen
- Blutungen
- Wechseljahresbeschwerden
- Die Resektion durch die Vagina: kann eine Ureterstenose, sowie Verengung der Vagina (Geschlechtsverkehrproblemen) auslösen

Warum nimmt Sie ASS ein? Kann ASS den Magen schäden? Normalerweise, nicht mit nur 100mg

Wogegen nimmt man ASS ein? Acetylsalicylsäure ist in vielen verschiedenen Indikationen anwendbar:

- **Thrombozytenaggregationshemmung**
  - Primärprophylaxe bei koronarer Herzkrankheit (KHK) ✓
  - akutes Koronarsyndrom (ACS): instabile Angina pectoris (iAP), akuter Myokardinfarkt (AMI)
  - Rezidiv- und Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt (Reinfarktprophylaxe)
  - Sekundärprävention nach transitorischen ischämischen Attacken (TIA) und Hirninfarkten (Schlaganfall)
  - Prävention von Gefäßverschlüssen bei pAVK
  - Prophylaxe von arteriellen Thrombosen nach gefäßchirurgischen Eingriffen, PTCA und Stentimplantationen
- **Analgesie**: leichte bis mittelschwere Schmerzen (Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Regelschmerzen etc.)

Warum nimmt sie Magnesium ein? Wegen Krampfen oder Müdigkeit

Empfehlen Sie Venoruton als Medikament?

Was muss beachtet werden, wenn der/die Pat. gegen Nickel allergisch ist? Bei Osteosynthese nickelhaltigen Nägel und Schrauben nicht benutzen.

Alkoholgehalt von Champagne: 10-12%

Hugo: 6.9%

Welche hochalkoholhaltigen Getränke kennen Sie? Rum, Wodka, Whisky, Absinth, Korn

Was ist Hugo? Ein Cocktail aus Prosecco, Zitronenmelisse- oder Holunderblüten-Sirup, frischer Minze und Mineral- oder Sodawasser

Arten von Apoplex?

= die plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns (= Hirnschlag) mit fokalen neurologischen Defiziten

- Der **<u>Ischämische Schlaganfall</u>** (= Hirninfarkt)
  - Ursache: **Gefäßverschluss** durch Ablagerungen (Cholesterin) / Blutgerinnsel (Thrombus) ✓
  - Unterversorgung der jeweiligen Hirnregion mit Sauerstoff und Nährstoffen ⇒ Nervenzellen sterben ab
  - Therapie: Rekanalisation (= Wiederöffnung eines Gefäßes)
    - Medikamentöse Thrombektomie = **Thrombolyse** (Achtung vor dem Zeitfenster: etwa 4 – 4,5 Stunden ab Symptombeginn) mit Alteplase (rt-PA = *recombinant tissue plasminogen activator*)
    - Operative **Thrombektomie** (Katheterintervention)
- Der **<u>hämorrhagische Schlaganfall</u>** (= Hirnblutung)
  - 2 Subtypen: Intrazerebrale Blutung (=ICB) / Subarachnoidalblutung

  - Ursachen: Hypertonie, Atherosklerose (weil die Gefäße leicht reißen.), Aneurysmen (Gefäßaussackung)
  - Unterversorgung der jeweiligen Hirnregion mit Sauerstoff und Nährstoffen ❑ Nervenzellen sterben ab
  - Therapie: OP (Hemikraniektomie, um Ödeme zu lindern)
- Die **TIA** = transitorische ischämische Attacke
  - wenn sich die Symptomatik < 24h wieder zurückbildet

Symptome:
- Lähmungen (halbseitige Lähmung = Hemiparese) ✓
- Sprach-, Seh-, und Gleichgewichtsstörungen (Aphasie, Hemianopsie) ✓
- Kopfschmerzen ✓
- Schwindel ✓
- Übelkeit und Erbrechen ✓
- Bewusstseinstrübung, Amnesie ✓

Aufnahme: < 3 Stunden für die beste Wirkung
- Intensivmedizinische Überwachung: Blutdruck, Herzfrequenz, Atmung, Zuckerwerte, Körpertemperatur, Nierenfunktion, Hirnfunktion, E-lyte und Wassergleichgewicht, Säuren-Basen-Haushalt

Was ist Gürtelrose? Herpes zoster ✓
Welche anderen Krankheiten verursacht das Virus? Windpocken (= Varizella)

Unterschied zwischen DM Typ 1 und 2?
- **Typ 1:** meist schleichender Beginn / meist junge Leute / oft schlank / Autoimmunursachen
  - **Mangel an Insulin** infolge einer Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas durch Autoimmunprozesse.
- **Typ2**: plötzlicher Beginn / meist ältere Leute / fast immer übergewichtig / falsche Ernährung und Bewegungsmangel
  - **Insulinresistenz** aufgrund einer chronischen Exposition gegenüber Hyperglykämie

Welche RF hat die Pat. Für Choledocholithiasis? 6F
- fat (Adipositas bzw. Hyperlipidämie) ✓
- female (weibliches Geschlecht) ✓
- fair (heller Hauttyp) ✓
- forty (Alter > 40 Lebensjahre) ✓
- fertile (Fruchtbarkeit, Schwangerschaft) ✓
- family (familiäre Disposition) ✓

Komplikationen von Choledocholithiasis:
- Cholezystitis (❑ Gallenblasenempyem = Eiteransammlung)
- Cholestatischer Ikterus
- Cholangitis (❑ Charcot-Trias: Gallenkolik, Ikterus, Fieber)
- Gallenblasenhydrops
- Pankreatitis
- Perforation ❑ Peritonitis

Was erwarten Sie bei der KU?
- **Courvoisier-Zeichen** (schmerzlos palpierbare Gallenblase)
  - = die Tastbarkeit einer vergrößerten, prall elastischen Gallenblase unter dem rechten Rippenbogen aber NICHT SCHMERZHAFT
- **Murphy-Zeichen**

- o = der Patient sitzt und bei tiefer Einatmung, palpieren wir eine Schmerzhafte Gallenblase unter den rechten Rippen. Der Patient kann nicht mehr Einatmen
- DS über OB und Epigastrium
- Abwehrspannung und Resistenz
- **Ikterus**
- Bei Komplikationen: Fieber, Abgeschlagenheit → Cholezystitis

Was ist Murphy-Zeichnen? Schmerzbedingter reflektorischer Abbruch der Inspiration während Abtasten

Welche Organe können durch Sono untersucht werden? Gallenblase, Pankreas, Gallenwege, Leber
Welche sonographischen Befunde erwarten Sie?

- Choledocholithiasis:
  - o **Konkremente mit dorsalem Schallschatten** als Hyperechogen (Echoreich / hell auf Ultraschall)
  - o **Dilatation des Gallengangs** (= Erweiterung)
  - o Wandverdickung der Gallenblase bei längerer Blockade
- Akute Cholezystitis / Cholezystolithiasis:
  - o **Wandverdickung** > 3 MM (postprandial > 5 MM)
  - o Mehrschichtung/Dreischichtung der Wand, ggf. mit umgebender freier Flüssigkeit im Gallenblasenbett
  - o Konkremente mit dorsalem Schallschatten
  - o **Vergrößerung der Gallenblasse**

Normbereich des Bilirubins: gesamt < 1.1 mg/dl, direkt < 0.3 mg/dl

Was machen Sie in der Notaufnahme? Was ist spezifischer, Lipase oder Amylase? Lipase
Ist es möglich, sofort eine Cholezystektomie durchzuführen? Nein, es ist besser, die OP nur in symptomfreien Zeiten (im symptomlosen Zustand) durchzuführen, d.h. nach Behandlung und Abklingen einer Gallenkolik (um die Komplikationen wie Infektion zu vermeiden).
Welches Analgetikum? Dosierung? Komplikationen?

- Metamizol bis zu 1000 mg pro Einzeldosis alle 6-8 Stunden
- Pethidin 25 bis 150 mg, Maximum Tagesdosis 500mg.
- NW:
  - o Pethidin: Nausea und Vomitus, Miktionsbeschwerden, Obstipation, Krampfanfall, Hypotonie,
  - o Metamizol: leukopenie und Agranulozytose, Hypotonie und Schock, Hautreaktionen, Nephro- und Lebertoxizität, Asthmaanfall

Litholyse? **Medikamentöse Auflösung von Steinen**. Ursodeoxycholsäure (= UDCA)
Lithotripsie? Extrakorporale **Zertrümmerung** von Konkrementen durch **Stoßwellen**

Komplikationen von Lithotripsie? Pankreatitis, Hauptgallengang Verschluss
Was ist Chirurgisches Konsil? es ist eine **ärztliche Beratung** durch einen anderen Spezialisten

14. Unkontrollierte Diabetes Mellitus / aHT s. 121 / s.2 (Neue)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Silvia Hammers
- 63 J.
- *24.12.1957
- 1,87 m
- 89,8 kg

Patient 1:

Victor von Hohenstahl
39 J.
✱ 28.01.1986
1,84 cm 95,2 kg

Cholelithiasis

Hauptbeschwerden

- seit 4 Stunden bestehende, plötzlich aufgetretene, persistierende, progrediente, kolikartige, Bauchschmerzen im rechten Oberbauch mit Ausstrahlung rechte Oberbauchschmerzen
- Auslöser: nach dem Verzehr von Lockbrötchen mit Sahne Soße
- die Schmerzintensität: 7/10 auf der NRS
- verstärkende Faktoren: Stehen
- lindernde Faktoren: Sitzen

Begleitsymptome

- Übelkeit seit 2 Stunden
- Erbrechen (2 Mal, bräunlich, Essensreste, ohne Blut)
- Diarrhoe (2 Mal, heute Morgen, weich, hellbraun, breiig, ohne Blut)
- dunkler Urin seit 2 Tagen

vegetative Anamnese

- Schweißausbrüche seit 3-4 Stunden
- Inappetenz
- stressbedingte ~~Dys~~ Dyssomnie

Vorerkrankungen

- Hypothyreose seit 10 Jahren (kontrolliert)

OPs

- linke Unterschenkelfraktur mit Missgabel vor 1 Jahr konservativ mit operativ behandelt
- nach OP Komplikation: Wundinfektion - Abszess ~~wieder OP~~ nach der Verletzung operativ behandelt

Medikamente

- L-Thyroxin 100 µg (1-0-0)
- Thromboyss unbekannte Dosis bzB.

Allergien/Unverträglichkeiten

- Erdbeeren, Kiwi (~~Urticaria Pruritus~~ Urticaria Pruritus, Exanthem, Ödem im Mund und Lippen)

Genussmittel

Nikotinkonsum: Nichtraucher

Alkoholkonsum: 2 Gläser Wein oder Bier 1-2 Mal pro Woche

Drogenkonsum: Kiffen 2 Mal pro Woche seit 2 Jahren

~~Familien~~ Familienanamnese

Vater: aHT, Herzkranzhart

Mutter: DM Typ II, Adipositas

Schwester: Downsyndrom

Sozialanamnese

- Beruf: Journalist
- Stress bei der Arbeit
- ledig
- wohnt mit ihrer Freundin
- keine Kinder

Verdachtsdiagnose

Choledocholithiasis

Differentialdiagnose

- Cholangitis
- Akute Pankreatitis
- Gastroenteritis

weitere Procedure

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor → gr. BB, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Lipidprofil, BZ, Amylase, Lipase, Cholestasewerte (GGT, ALP, Bilirubin), Stuhldiagnostik
- Sonographie Abdomen
- ggf. ~~MRCP~~ CT Abdomen
- ein gastroenterologisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr
- Elektrolytsubstitution
- Analgetikum
- Antiemetikum
- Antipyretikum
- Spasmolytikum

- Lebensstilveränderungen: (Gewichtsreduktion, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung)
- ggf. ERCP
- ggf. Antibiotikum

Pethidin ist ein starkes Opioid-Analgetikum zur Behandlung starker akuter Schmerzen, z. B. bei Koliken oder postoperativen Schmerzen.

Metamizol ist ein starkes Analgetikum und Antipyretikum mit spasmolytischer Wirkung, häufig eingesetzt bei Koliken und starken Schmerzen

18.5 >	Untergewicht
18.5 - 24.9	Normalgewicht
25 - 29.9	Übergewicht
30 - 34.9	Adipositas Grad I
35 - 39.9	Adipositas Grad II
40 <	Adipositas Grad III (morbide Adipositas)

✓ Gürtelrose ist nur dann ansteckend, wenn Flüssigkeit aus den Bläschen in direkten Hautkontakt kommt. Selbst geimpfte Personen können sich selten anstecken, würden dann aber Windpocken und nicht Gürtelrose bekommen.

Die Beinvenen können das Blut nicht mehr richtig nach oben transportieren. Deshalb staut sich das Blut in den Beinen, was zu Schwellungen, Schmerzen und Hautveränderungen führt.

→ özellikle az sonra sizinkiyle ortaklaşa

"Dadurch sammelt sich das Blut in den Beinen."

"Aufgrund der Schweigepflicht werde ich Ihre Angaben mit niemandem teilen."

Soll ich operiert werden?

→ Es ist jetzt zu früh zu entscheiden. Ich informiere Sie alles nach dem Untersuchung.

Soll ich hier bleiben?

→ Momentan kann ich nicht das genau wissen. Wir warten auf die Befunde der Untersuchung, dann können wir entscheiden.

(Sümeyra Hocanın yanıtları)

"Varizen sind ein Problem der Blutgefäße im Körper, besonders der Venen in den Beinen."

Durisch

- Schwangerschaft olup olmadığını bilmek önemli.
  - Ayırıcı tanı
  - Varlıklı loco sayısı ve
  - Tedavinin belirlenmesi
- ERCP'yi hem tanısal hem de terapötik olarak sık kullanıyoruz

Nesselsucht → Ürtiker / Kurdeşen?

Choledocholithiasis

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Leopald Busch, Rose Marie Hagen
Alter: 40 Jahre (geb. am 11.01.1985) ,59
Größe: 1,84 m
Gewicht: 94.4 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- seit 4 T. plötzlich aufgetretene, bestehende, postprandiale, progrediente, kolikartige Bauchschmerzen im rechten Oberbauch, mit Ausstrahlung in die rechte Schulter.
- Die Schmerzintensität: 7/10 auf der NRS
- Auslöser: Verzehr von Lachsbrötchen/ Makrelen Röllchen + butter
- Lindernde Faktoren: Sitzen
- Verstärkende Faktoren: Stehen
- Ähnliche, aber leichtere postprandiale Schmerzen seit 8 Wo., progredienter Verlauf.

Begleitsymptome:

- Nausea: seit 1 Wo.
- Emesis: 2 Mal, heute Morgen (Essensreste, gelblich, ohne Blut)
- Diarrhö (dünner Stuhl, seit 8 W, 2 Mal/T, hellbraun, ohne Blut)
- dunkler Urin (seit 3 stunden)

V/A:

- Inappetenz
- Müdigkeit
- schmerzbedingte Dyssomnie

G/A:

Unregelmäßige Menstruation (letzte Periode vor 15 Tagen).

V/E:

Hypothyreose, seit 10 J., kontrolliert.

M:

L-Thyroxin 100 µg 1-0-0.
Thomapyrin b.B

Magnesium 1-0-0
ASS 100 mg 1-0-0
Venoruton 300 mg 1-0-1 wegen CVI (chronische venenInsuffizienz)

Vor-op:

Linke Unterschenkelverletzung vor 2 Jahren, konservativ therapiert
Komplikation: Wundinfektion 2 Wochen nach der Verletzung, operativ behandelt

---

TE mit dem 10 LJ.
Hysterektomie (total) vor 10 J. (Benign Tumor)

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Erdbeere- und Kiwiallergie (Exanthem und Pruritus)

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 1–2 Gläser Champagner pro Monat (Hugo)
- Drogenkonsum: Cannabis, 1-2 Mal/M

- **Sozialanamnese:**

  Journalist
  Ledig, in einer festen Beziehung
  keine kinder

  _____
  Managerin ihres Mannes
  Verheiratet . 2 Tochter

- **Familienanamnese:**

  Vater:aHT
  Mutter: Adipositas, DM- Typ 2
  Schwester: Down-Syndrom

- **Verdachtsdiagnose:**

  Choledocholithiasis

- **Differentialdiagnose**

  ACS
  Ulcus ventriculi
  Cholezystitits
  Akute Pankreatitis

- **weitere Diagnostik**

- KU -EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - Amylase und Lipase - Elektrolyte - Cholestaseparameter
- Urinstatus
- Stuhluntersuchung
- Sono Abdomen
- Ggf CT Abdomen
- Ggf ERCP

- **Therapievorschläge**

- Stationäre Aufnahme

- Nahrungskarenz
- Antiemetikum
- Analgetikum (Metamizol) b.B.
- Spasmolytikum
- Ggf. Antibiotikum (Ceftriaxon und Metronidazol)
- Ggf. Cholezystektomie

In Deutschland gibt es nur eine gesetzliche verpflichtende Impfung: die Masernimpfung für Kinder und bestimmte Berufsgruppen (z.B. in Kitas, Schulen und im Gesundheitswesen). Alle anderen Impfungen werden von der STIKO empfohlen, sind aber nicht allgemein verpflichtend

EFA Doğru Omega-3!
New Life

Landtagsabgeordnete sind gewählte Abgeordnete die im Parlament eines Bundeslandes in Deutschland tätig sind.

Grüne Partei

Die Partei „Die Grünen" verbindet (kurzgefasst) ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.

Zweifel- Sophie

Ich habe Zweifel an der Übertragung

Die häufigsten Erreger der Gastroenteritis sind Viren (Norovirus, Rotavirus) Bakterien (Salmonella, Campylobacter) und Parasiten (Giardia)

In Deutschland sind gastrointestinale Erreger Norovirus, Rotavirus, Salmonella, Shigella, EHEC, Campylobacter und bestimmte Parasiten (z.B Giardia) nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig →

Gastroenteritis

Bei der Blutdruckmessung wird der Druck gemessen, mit dem das Blut gegen die Gefäßwände drückt. Es gibt zwei Werte: der systolische Wert, wenn das Herz pumpt, und der diastolische Wert wenn das Herz sich entspannt. Der obere Wert zeigt den Druck beim Herzschlag, der untere Wert den Druck →

Für Erwachsene empfohlene Impfungen

Tetanus - Diphtherie - Auffrischung

Keuchhusten (einmalige Auffrischung)

Covid 19

Influenza (Grippe)

Pneumokokken

Herpes zoster (Gürtelrose)

EFA Doğru Omega-3!
New Life

New Life
EFA Doğru Omega-3!

Mumps – Ziegenpeter – Parotitis epidemica

Mumps wird durch ein Virus aus der Gruppe der Paramyxoviren verursacht. Die Krankheit führt vor allem zu einer schmerzhaften Schwellung der Ohrspeicheldrüse. Die Beste Schutz ist die MMR-Impfung

Deutsche Welle ist ein internationaler deutscher Sender mit Nachrichten und Informationen

Mirizzi Syndrom

Beim Mirizzi Syndrom drückt ein Gallenstein im Bereich des Gallenblasenhalses von außen auf den Hauptgallengang und